

RESUMEN:

Nombre Inv. Responsable:	<u>Vanetza Estela Quezada Scholz</u>
Título Proyecto:	Terapia de exposición maximizada para el tratamiento y prevención de recaídas en trastornos de ansiedad: un ensayo clínico aleatorio longitudinal

La Terapia Cognitivo Conductual (TCC) es considerada un tratamiento de primera línea para los trastornos de ansiedad (TA; APA, 2017), siendo la exposición al objeto o situación temida, el componente central en dichas intervenciones (Knowles et al., 2022). No obstante, si bien la terapia de exposición ha demostrado efectividad en la reducción de sintomatología, la reducción del miedo durante la exposición no predice necesariamente sus efectos a largo plazo (Craske et al., 2022). Un porcentaje importante de pacientes tienen recaídas posterior a un tratamiento exitoso (entre 19% y 62%; Craske, 2015), siendo éstas uno de los mayores retos de la TCC. El retorno del miedo y la ansiedad posterior al tratamiento en los trastornos de ansiedad, ha motivado el estudio de los mecanismos de la terapia de exposición y cómo estos mecanismos pueden ser maximizados para prevenir el retorno del miedo posterior al tratamiento, lo que ha derivado en recomendaciones para la maximización de los resultados de la terapia de exposición basadas en la investigación traslacional (Craske et al., 2015, 2022; Laborda et al., 2011; Vervliet et al., 2013), cuyo cuerpo de conocimientos permite plantear que, son al menos dos los mecanismos que subyacen a las técnicas conductuales para prevenir la recuperación de lo extinguido en el laboratorio y en la terapia de exposición (Laborda y Miller, 2012): 1) fortalecer el aprendizaje de extinción y 2) facilitar la consolidación, generalización y recuperabilidad del aprendizaje de extinción.

Existe una brecha en la traducción de los conocimientos de la investigación básica, en extinción y recuperación del miedo, a la terapia de exposición para mejorar sus resultados en el largo plazo y prevenir recaídas. A la fecha son escasos los estudios que evalúan la eficacia de la terapia de exposición maximizada (Pittig et al., 2021; Blakey et al., 2019), y tienen la limitación de utilizar una o dos técnicas que responden a un solo mecanismo para prevenir el retorno del miedo. Estos estudios corroboran la eficacia de la terapia de exposición maximizada y estándar en la reducción de la ansiedad al final del tratamiento, sin diferencias entre ambos tipos de tratamiento ni en los resultados finales ni en el seguimiento a 1 o 6 meses y, por lo tanto, no resuelven el mayor problema de la terapia de exposición, a saber, una alta probabilidad de recaída. Dado que la evidencia sugiere que un proceso de exposición mejorará sus resultados en el largo plazo en la medida que integre técnicas que respondan a los dos mecanismos señalados, la presente propuesta, tiene como **objetivo general**, evaluar la eficacia de un protocolo de exposición maximizado para los trastornos de ansiedad (PEM-TA), en la disminución de sintomatología asociada al problema al final del tratamiento y en los seguimientos a los 6, 12 y 18 meses luego de su inicio. A diferencia de estudios previos, el PEM-TA está maximizado con un grupo de técnicas que actúan en base a los dos mecanismos que están a la base de la prevención del retorno del miedo posterior al tratamiento, poniendo a prueba la eficacia de la exposición maximizada para prevenir recaídas en el largo plazo por primera vez. **El estudio se realizará a través de un ensayo clínico aleatorio** en que se comparan los efectos de dos grupos activos, PEM-TA y Protocolo de Exposición Estándar (PEE), aplicado a una muestra estimada de 200 adultos con trastornos de ansiedad asociados a objetos o situaciones (Trastorno de Pánico; Agorafobia; Ansiedad Social; fobia específica) como diagnóstico principal. Los participantes que cumplan los criterios de elegibilidad serán asignados aleatoriamente a uno de los grupos de tratamiento. Los terapeutas con formación cognitivo conductual serán entrenados para la aplicación de ambos protocolos y supervisados semanalmente mientras realizan la intervención. Los tratamientos se llevarán a cabo en el Centro Aplicado de Psicología de la Universidad de Chile (CAPs). Previo al tratamiento se realizará una medición de línea base (LB) con el *Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure* (CORE-OM; Feixas et al., 2012) y el *Beck Anxiety Inventory* (BAI; Sanz y Navarro, 2003). El CORE-OM será aplicado nuevamente luego de las sesiones 3, 6, 9 y 12. En la medición de la sesión 12 se volverá a aplicar el BAI. Durante la exposición serán evaluados en línea y repetidamente para obtener una índice sesión a sesión de las expectativas de amenaza y ansiedad. Se realizan seguimientos a través del CORE-OM y BAI a 6, 12 y 18 meses de terminado el tratamiento. **Se espera que los participantes de ambos grupos mejoren significativamente** la sintomatología principal asociada al problema a los 3 meses luego del inicio del tratamiento, mientras que aquellos que recibieron la exposición maximizada presentarán niveles bajos de sintomatología principal asociada al problema a los 6, 12 y 18 meses de inicio del tratamiento, en comparación con los participantes del grupo de exposición estándar.